

# INFORME PSICOLÓGICO CLÍNICO

## I. DATOS PERSONALES.

**Nombre:** Fredy Zegarra **Fecha de nacimiento:** 29.03.1990

**Edad:** 36 años

**Fecha de evaluación:** 07, 08 y 11 de mayo

**Derivación:** Psiquiatría

## II. MOTIVO DE CONSULTA

Paciente derivado por psiquiatría para evaluación clínica especializada y descarte de Trastorno del Espectro Autista (TEA) mediante administración de ADOS-2 Módulo 4. Refiere antecedente diagnóstico previo de Trastorno Esquizoafectivo tipo depresivo.

## III. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

- Entrevista clínica semiestructurada.
- Observación conductual.
- ADOS-2 Módulo 4 (Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition).

## IV. OBSERVACIÓN CLÍNICA

Durante la evaluación, Freddy se mostró colaborador, orientado y ampliamente comunicativo. Desde el inicio estableció interacción espontánea y tendencia a la familiaridad conversacional, manteniendo disposición activa a compartir información personal, académica y relacional.

Presentó lenguaje fluido, formal y altamente elaborado, con tendencia a extenderse en explicaciones técnicas, análisis conceptuales y asociaciones amplias entre temas. Su estilo discursivo se caracterizó por elevada productividad verbal, precisión terminológica y necesidad de profundización en los temas abordados.

A nivel no verbal se observaron:

- Adecuado contacto visual,
- Expresividad facial congruente,
- Uso funcional e integrado de gestos,
- Modulación prosódica conservada,
- Adecuada sincronía interactiva.

Demostró capacidad para comprender dobles sentidos, matices emocionales y dinámicas interpersonales complejas. Asimismo, evidenció interés genuino en la interacción social y adecuada lectura contextual del entorno.

Durante la entrevista destacó una elevada capacidad de observación, identificando detalles específicos del ambiente y de la evaluadora. Se observó además tendencia a la racionalización de experiencias emocionales, necesidad de coherencia lógica y marcada sensibilidad frente a situaciones percibidas como injustas, humillantes o contradictorias con sus principios personales.

No se evidenciaron alteraciones conductuales mayores, lenguaje desorganizado, conductas bizarras ni indicadores observacionales compatibles con desregulación psicótica activa.

## **V. ANTECEDENTES RELEVANTES**

El evaluado refiere haber cursado estudios en aproximadamente seis instituciones educativas debido al trabajo de su padre, quien se desempeñaba como oficial de policía. Describe que dichos cambios le permitieron exponerse a distintas realidades sociales y escolares.

Menciona haber presentado desde etapas tempranas un desempeño académico sobresaliente, obteniendo frecuentemente los primeros puestos y desarrollando una modalidad de aprendizaje predominantemente autodidacta. Refiere poseer un coeficiente intelectual elevado y manifiesta amplio interés por conocimientos técnicos y teóricos.

Describe experiencias significativas de conflicto escolar y elevada sensibilidad frente a situaciones interpretadas como vejatorias o injustas. Relata que un episodio de agresión física durante la adolescencia generó rechazo importante hacia el contexto escolar tradicional y pérdida progresiva del interés académico.

Posteriormente logró incorporarse a un colegio de alto rendimiento, experiencia que recuerda de manera más favorable debido a la ausencia de violencia interpersonal.

Más adelante ingresó a la Universidad Católica San Pablo; sin embargo, refiere conflictos ideológicos relacionados con contenidos vinculados a Luis Figari y el Sodalicio, situación que culminó con su retiro de la institución.

Actualmente trabaja en el desarrollo de software, mantiene intereses intelectuales amplios y continúa viviendo con sus padres.

En el área afectiva, refiere haber mantenido dos relaciones sentimentales significativas y expresa interés genuino en formar una familia en el futuro.

## **VI. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ADOS-2 MÓDULO 4**

Durante la administración del ADOS-2 Módulo 4 no se evidenciaron dificultades nucleares compatibles con Trastorno del Espectro Autista.

El evaluado mostró:

- Adecuada reciprocidad socioemocional,
- Capacidad para sostener conversaciones bidireccionales,
- Comprensión de emociones propias y ajenas,
- Adecuada utilización de comunicación verbal y no verbal,
- Comprensión de normas sociales implícitas,
- Capacidad de introspección,
- Mantenimiento de vínculos afectivos significativos.

Asimismo, logró integrar experiencias emocionales complejas dentro de una narrativa coherente, mostrando interés genuino en las relaciones humanas y adecuada comprensión contextual.

Sí se observaron características como:

- Rigidez cognitiva,
- Estilo comunicativo intenso,
- Tendencia a la sobreexplicación,
- Intereses específicos y profundos,
- Necesidad de precisión conceptual,
- Marcada intelectualización del discurso.

No obstante, dichas características no configuran el patrón cualitativo esperado en TEA, dado que no se observaron alteraciones persistentes en reciprocidad social, comunicación pragmática ni conductas restringidas con impacto clínicamente significativo.

### **Puntuación estimada ADOS-2**

- **Área A (Comunicación e interacción social):** 1
- **Área B (Conductas restrictivas/repetitivas):** 2
- **Total estimado:** 3 puntos

### **Punto de corte clínico**

- **TEA:**  $\geq 7$  puntos

El paciente se encuentra significativamente por debajo del punto de corte clínico para espectro autista.

## VII. ANÁLISIS CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Las características observadas durante la evaluación parecen vincularse principalmente con:

- En estilo de personalidad rígido y altamente analítico,
- Elevada intelectualización,
- Necesidad de estructura y coherencia,
- Sensibilidad frente a experiencias de desvalorización,
- Presencia de rasgos obsesivos de personalidad.

El evaluado demuestra habilidades sociales funcionales, capacidad de adaptación contextual, comprensión emocional preservada e interés genuino en la interacción interpersonal, elementos que se alejan del perfil clínico típico observado en Trastorno del Espectro Autista.

Respecto al diagnóstico previo de Trastorno Esquizoafectivo tipo depresivo, durante la presente evaluación no se identificaron indicadores compatibles con:

- Desorganización formal del pensamiento,
- Alteraciones significativas del juicio de realidad,
- Sintomatología psicótica activa,
- Ni deterioro severo de la comunicación interpersonal.

Si bien el paciente presenta un estilo cognitivo peculiar, intenso y marcadamente intelectualizado, este mantiene coherencia lógica, direccionalidad y adecuada capacidad de adaptación conversacional.

En consecuencia, las características observadas resultan más compatibles con rasgos de personalidad obsesivos y un funcionamiento cognitivo de alta complejidad intelectual que con un cuadro del neurodesarrollo tipo TEA.

## VIII. CONCLUSIONES

Los resultados de la evaluación clínica y de la administración del ADOS-2 Módulo 4 permiten descartar Trastorno del Espectro Autista.

El perfil observado es más consistente con:

- Rasgos obsesivos de personalidad,
- Estilo cognitivo altamente intelectualizado,
- Rigidez cognitiva e interpersonal,
- Elevada necesidad de coherencia lógica,
- Sensibilidad significativa frente a experiencias percibidas como injustas o desvalorizantes.

No se evidencian alteraciones nucleares de reciprocidad social, comunicación pragmática ni patrones conductuales restrictivos compatibles con TEA.

## **IX. RECOMENDACIONES**

### **Para el paciente**

- Continuar acompañamiento psicológico orientado al fortalecimiento de flexibilidad cognitiva y regulación emocional.
- Trabajar terapéuticamente manejo de perfeccionismo, tolerancia a la frustración y modulación de intensidad comunicativa.
- Favorecer espacios de interacción social compatibles con sus intereses intelectuales y profesionales.
- Explorar estrategias de diferenciación entre pensamiento analítico y procesamiento emocional.
- Promover mayor equilibrio entre autoexigencia, validación interpersonal y bienestar subjetivo.

### **Para la familia**

- Mantener comunicación abierta, clara y no confrontativa.
- Evitar invalidar o ridiculizar sus intereses y formas de razonamiento.
- Favorecer dinámicas familiares flexibles y respetuosas de su autonomía.
- Promover espacios de escucha emocional sin centrarse exclusivamente en el rendimiento intelectual.

### **Evaluadora:**

Luciana Marcela Lazo Delgado

Psicóloga Clínica

[C.Ps.](#)P: 46127 DNI: 72606014